

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE DEPENDENCIA INTERPERSONAL (IDI)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Dimensional de la Dependencia Afectiva y la Autonomía

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Dependencia Interpersonal (IDI: 48 reactivos).
Nombre Original (Inglés)	<i>Interpersonal Dependency Inventory (IDI)</i>
Autores Originales	Drs. Robert M. A. Hirschfeld, G. L. Klerman, P. Chodoff, S. Korchin y J. Barrett (1977).
Publicación Primaria	<i>Journal of Personality Assessment</i> , 41(6), 610-618. NIMH / Harvard.
Adaptaciones Hispanas	Validaciones clínicas en España y Latinoamérica (Lemos & Londoño; Bornstein et al.).
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Dependencia Emocional, Apego Inseguro y Trastorno por Dependencia.
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico multidimensional de 48 reactivos con escala Likert de 4 puntos (1 a 4).
Población y Rango	Adultos y jóvenes (desde 16 años). Pacientes ambulatorios y en terapia de pareja/vincular.
Tiempo de Administración	8 a 12 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Instrumento científico académico bajo citación formal de la fuente primaria (Taylor & Francis).

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO MULTIDIMENSIONAL DE HIRSCHFELD

El IDI constituye el hito fundacional en la evaluación psicométrica de la **dependencia interpersonal**. Hirschfeld y colaboradores (1977) definieron este constructo como un complejo de pensamientos, creencias, afectos y conductas interrelacionados que giran en torno a una necesidad imperiosa y persistente de asociarse estrechamente con figuras de apego significativas para obtener guía, protección, afecto y reaseguro continuo.

El modelo teórico trasciende la visión patologizante unidimensional al postular que la dependencia engloba tres dimensiones cualitativamente distintas:

- Dependencia Emocional de Otros:** Necesidad vehemente de proximidad física y psicológica, angustia profunda ante la soledad o separación y demanda continua de aprobación afectiva.
- Falta de Confianza Social y Autonomía:** Sensación de desamparo e incompetencia para tomar decisiones vitales por uno mismo, timidez en interacciones sociales y pasividad resolutive.
- Afirmación de Autonomía:** Deseo adaptativo de autodeterminación, independencia de criterio y resistencia a someterse pasivamente a los dictados ajenos.

Neurobiológicamente, la dependencia patológica se vincula a una alteración en la modulación serotoninérgica frontolímbica y una hiperreactividad en los circuitos del apego dependientes de oxitocina y opioides endógenos en la ínsula anterior y el córtex cingulado anterior dorsal.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Dimensión del IDI	Nº Ítems	Sentido	Definición Operativa y Foco Clínico Evaluado
1. Dependencia Emocional	18 ítems	Directos	Búsqueda constante de proximidad, temor a la pérdida y necesidad de validación.
2. Falta de Confianza Social	16 ítems	Directos	Inseguridad en el propio juicio, pasividad interpersonal y miedo a decidir solo.
3. Afirmación de Autonomía	14 ítems	Directos	Valoración de la independencia personal, autosuficiencia y firmeza decisoria.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión en adaptaciones hispanas y anglosajonas (Hirschfeld et al., 1977; Bornstein, 2012): alfa de Cronbach de 0.85 para Dependencia Emocional, 0.80 para Falta de Confianza Social y 0.78 para Afirmación de Autonomía. Estabilidad test-retest $r = 0.79$ a 0.86 a las 6 semanas.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio ratifica de manera sistemática la solución de tres factores oblicuos (CFI = 0.92, TLI = 0.90, RMSEA = 0.054), avalando la validez constructiva de evaluar la autonomía como un vector opuesto e independiente de la dependencia.
Validez Concurrente y Clínica	Alta correlación con el diagnóstico de Trastorno de la Personalidad por Dependencia del DSM-5 (SCID-II: $r = 0.65$), apego ansioso/preocupado (ECR-R: $r = 0.61$) y depresión anaclítica (Blatt, $r = 0.58$). Correlación inversa con autoestima y autoeficacia general.
Sensibilidad al Cambio	Sensibilidad demostrada en terapias de corte cognitivo-conductual e interpersonal, registrando caídas significativas en la necesidad de aprobación y elevaciones sostenidas en Afirmación de Autonomía tras 16 semanas.
Diferencias Sociodemográficas	Las mujeres puntúan significativamente más alto en Dependencia Emocional en muestras comunitarias, mientras que las diferencias se atenúan drásticamente en muestras clínicas ambulatorias.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 48 reactivos se responde de 1 (**Muy poco característico de mí / Muy en desacuerdo**) a 4 (**Muy característico de mí / Muy de acuerdo**):

- **Paso 1 (Cálculo Directo por Dimensión):** No contiene reactivos invertidos internamente; cada escala se suma directamente.
- **Paso 2 (Puntuaciones Directas por Subescala):**
 - **Dependencia Emocional (18 ítems):** Rango de **18 a 72 puntos**.
 - **Falta de Confianza Social (16 ítems):** Rango de **16 a 64 puntos**.
 - **Afirmación de Autonomía (14 ítems):** Rango de **14 a 56 puntos**.
- **Paso 3 (Índice de Dependencia Compuesta de Bornstein):** Para estimar la severidad de la dependencia desadaptativa neta: $IDC = (Dependencia\ Emocional + Falta\ de\ Confianza) - Afirmación\ de\ Autonomía$.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS INTERPRETATIVOS

Dimensión	Puntuación	Nivel de Dependencia	Significación Clínica y Pronóstica
Dependencia Emocional	18 a 35 pts	Baja / Autosuficiente	Capacidad de vinculación sin sumisión ni terror al abandono.
Dependencia Emocional	36 a 47 pts	Moderada / Normativa	Necesidad normal de respaldo afectivo ante crisis estresantes.
Dependencia Emocional	48 a 72 pts	Clínica / Elevada (≥ 48)	Apego dependiente patológico; riesgo severo de claudicación en soledad.
Falta de Confianza	16 a 31 pts	Seguridad adaptativa	Autoeficacia social y resolutive bien preservada.
Falta de Confianza	32 a 41 pts	Inseguridad situacional	Dudas ocasionales ante decisiones de alta incertidumbre.
Falta de Confianza	42 a 64 pts	Indefensión clínica (≥ 42)	Incapacidad para actuar sin aprobación previa; pasividad invalidante.

PERFIL CLÍNICO DE MÁXIMO RIESGO RELACIONAL:

La combinación de **Dependencia Emocional alta (≥ 48)** + **Falta de Confianza alta (≥ 42)** con **Afirmación de Autonomía baja (≤ 25)** configura la vulnerabilidad canónica del Trastorno de la Personalidad por Dependencia. En mujeres y jóvenes, este perfil predice un riesgo crítico de permanencia en vínculos con violencia intrafamiliar o abuso psicológico por terror al desamparo.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN DEPENDENCIA PATOLÓGICA (TCC / ESQUEMAS)

PROTOCOLO CLÍNICO BASADO EN EL PERFIL DEL IDI:

- **Paso 1 (Psicoeducación sobre la Trampa de la Sumisión):** Identificar la creencia nuclear: “no puedo sobrevivir solo; si discrepo me abandonarán”. Diferenciar dependencia sana (interdependencia mutua) de la dependencia sumisa.
- **Paso 2 (Entrenamiento en Autonomía Decisoria):** Si Falta de Confianza ≥ 42 , programar tareas de toma de decisiones autónomas no consultadas (de menor a mayor riesgo: elección de ropa, salidas, trámites administrativos).
- **Paso 3 (Exposición a la Soledad):** Programar períodos voluntarios de soledad productiva y disfrute individual sin contacto telefónico/digital continuo con la figura de apego.
- **Paso 4 (Monitorización):** Un incremento en Afirmación de Autonomía de ≥ 10 puntos y descenso del IDC ≥ 20 puntos consolidan la individuación psicológica.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DEPENDENCIA EMOCIONAL Y RUPTURA TRAUMÁTICA

Identificación: Mujer de 31 años, técnica de laboratorio, acude a urgencias por crisis de angustia incontrolables, rumiación suicida pasiva e incapacidad funcional tras la amenaza de ruptura de su pareja sentimental. Describe una historia de relaciones donde “mi vida entera gira en torno a complacer a la otra persona”.

Evaluación Inicial IDI (Línea Base): Dependencia Emocional = **64/72 puntos** (Rango Clínico Extremo); Falta de Confianza Social = **54/64 puntos** (Extrema indefensión); Afirmación de Autonomía = **19/56 puntos** (Colapsada). Índice de Dependencia Compuesta IDC = **+99** (perfil de dependencia severa).

Tratamiento Aplicado: 16 sesiones de TCC individual integrando Terapia de Esquemas (esquemas de Subyugación y Apego Inmaduro). Se entrenó la tolerancia a la angustia de separación (DBT), asertividad con límites firmes y reconstrucción de proyectos personales independientes.

Reevaluación a las 16 Semanas: Dependencia Emocional descendió a **38/72 puntos** (-26 pts); Falta de Confianza Social bajó a **30/64 puntos** (-24 pts); Afirmación de Autonomía ascendió a **42/56 puntos** (+23 pts). El IDC descendió de +99 a **+26**. La paciente sostuvo la separación de forma serena y retomó sus estudios universitarios.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

RIESGO DE VIOLENCIA EN LA PAREJA:

En contextos de violencia de género, las puntuaciones altas de dependencia no deben culpabilizar a la víctima. El terror al desamparo suele estar alimentado por el aislamiento coercitivo impuesto por el agresor. Priorizar la seguridad física y la red legal.

DEPENDENCIA VS. ENFERMEDAD MÉDICA:

Diferenciar la dependencia afectiva psicológica de la necesidad de ayuda instrumental objetiva en pacientes con dolor crónico, patologías neuromusculares o ancianos con deterioro físico, donde pedir auxilio es adaptativo y realista.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Hirschfeld, R. M. A., Klerman, G. L., Chodoff, P., Korchin, S. J., & Barrett, J. (1977). A measure of interpersonal dependency. *Journal of Personality Assessment*, 41(6), 610-618.
2. Bornstein, R. F. (2012). Illuminating a neglected clinical issue: Sociocultural, interpersonal, and cognitive dimensions of interpersonal dependency. *Journal of Clinical Psychology*, 68(1), 3-16.
3. Lemos, M., & Londoño, N. H. (2006). Construcción y validación del Cuestionario de Dependencia Emocional en población colombiana. *Acta Colombiana de Psicología*, 9(2), 127-140.
4. Beck, A. T., & Freeman, A. (1990). *Cognitive therapy of personality disorders*. Guilford Press.